جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال احمد الشيخ محمد خليفه
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** الفيوم
رقم البطاقة : 28007292300441 **رقم التليفون :** 01027099925 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 29-07-1980 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منال احمد الشيخ محمد خليفه
National ID: 28007292300441

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

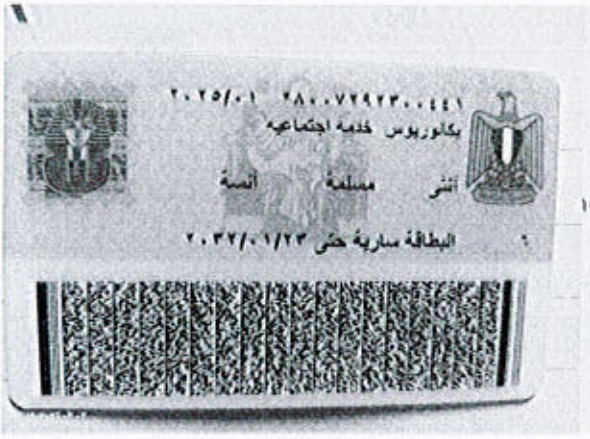
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

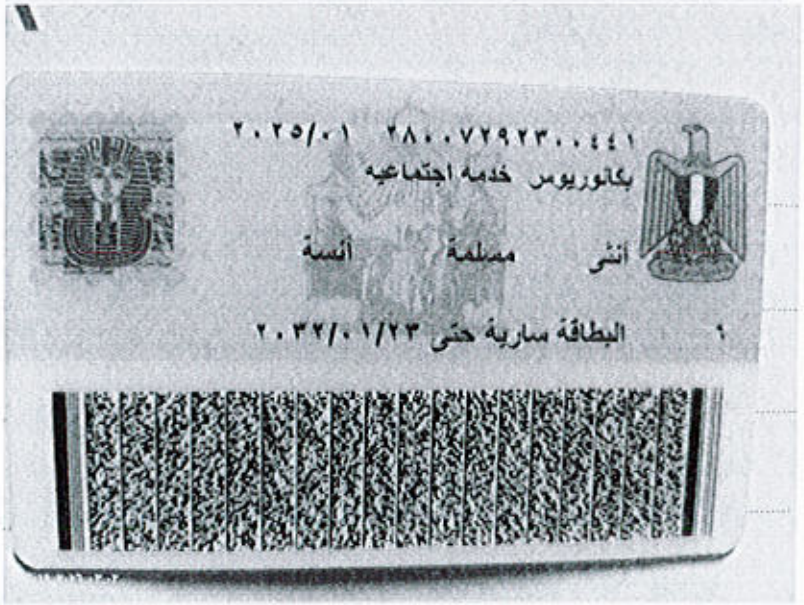
التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين







DMS
تدعيم



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Hematology Analysis Report

First Name:
Gender:
Department:
Mode: Autoloader-WB-CBC+DIFF
Diagnosis:

Last Name:
Age:
Bed No.:

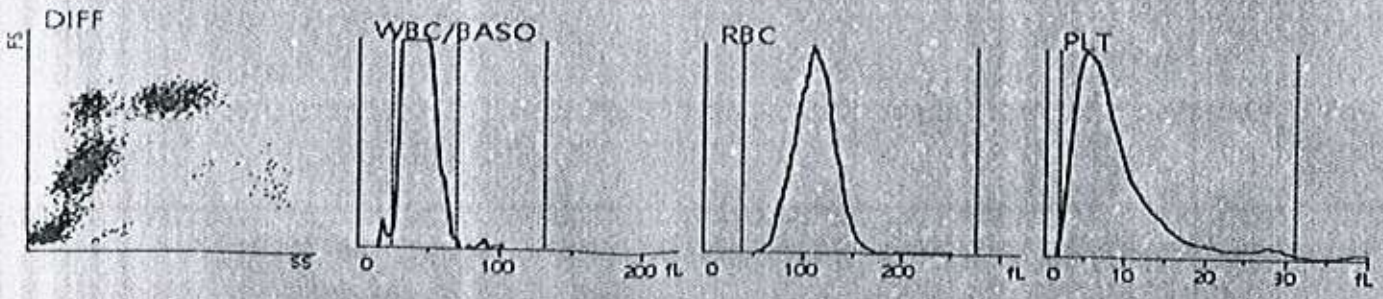
Sample ID: manal ahmed elshekih 24
Patient ID:
Run date: 2/6/2026 10:49 AM

Parameter	Result	Unit	Ref. range
1 WBC	3.23	10^3/uL	
2 Neu#	1.19	10^3/uL	
3 Lym#	1.66	10^3/uL	
4 Mon#	0.33	10^3/uL	
5 Eos#	0.04	10^3/uL	
6 Bas#	0.01	10^3/uL	
7 Neu%	36.7	%	
8 Lym%	51.4	%	
9 Mon%	10.3	%	
10 Eos%	1.3	%	
11 Bas%	0.3	%	
12 RBC	2.65	10^6/uL	
13 HGB	9.4	g/dL	
14 HCT	27.6	%	
15 MCV	104.1	fL	
16 MCH	35.5	pg	
17 MCHC	34.1	g/dL	
18 RDW-CV	16.8	%	
19 RDW-SD	65.4	fL	
20 PLT	155	10^3/uL	
21 MPV	9.6	fL	
*22 PDW	16.9		
*23 PCT	0.149	%	
*24 P-LCC	29	10^9/L	
*25 P-LCR	18.7	%	
*26 ALY#	0.00	10^3/uL	
*27 ALY%	0.0	%	
*28 LIC#	0.00	10^3/uL	
*29 LIC%	0.0	%	
*30 NRBC#	0.004	10^9/L	
*31 NRBC%	0.13	%	

WBC Message

RBC Message
Anisocytosis

PLT Message



Delivered by:
Order Time:
Comments:

Operated by: admin
Draw Time:

Validated by:
Print Time: 2/6/2026 11:03:17 AM

[The analysis results only answer to the corresponding sample]
*For research use only, not for diagnostic use.

Name: منال احمد الشيخ محمد **MR. :** 2535	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was noted to have metastatic breast cancer (MBC) with bone involvement and was started on faslodex at the Bahyia facility, along with Ibrance 1250 mg; a CT CAP was performed on 28-2-2026 and laboratory results were reported as acceptable.

Subsequently, the patient received Zoladex, faslodex, and Zometa at Bahyea on the same day, administered in preparation for continuation of Ibrance therapy after review of laboratory studies.

The most recent encounter documented administration of Ibrance alone at a dose of 125 mg following laboratory evaluation, with a complete blood count reported as within normal limits.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Reham Ahmed Fathy Ibrahim**

يعتمد ,

appendicular skeleton sclerotic lesions.
- No CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

** *Status follow up showing*

- *Regressive course of the:*

1. *Right breast inframammary lesion.*
2. *Anterior mediastinal soft tissue density, likely prominent thymus tissue.*
3. *Amount of the mild peri-hepatic, right para-colic, perisplenic and pelvic ascites.*
4. *Diffuse omental fat smudging.*

- *Stationary rest of the study.*

Reported By,
Dr. Ali Saber, MSc
Dr. Reham Anwar, FEBR, MD 03-Mar-2026 01:50 PM

www.Baheya.org 16602
مركز بهية للورم
٨ شارع علوية أول شارع الورم بجوار دارى . الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤ الحي الأول . الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size.
- No pericardial effusion detected.
- **Regressive course** of the anterior mediastinal soft tissue density measuring about 14 x 7 mm compared to 20 X 13 mm along maximum axial dimensions, likely prominent thymus tissue.

3- ABDOMEN AND PELVIS:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No sizable focal lesions.
- Cholecystectomy clips are noted with **still seen** mildly dilated intra-hepatic and extra-hepatic biliary radicles as well as pancreatic duct.
- Normal size and parenchymal density of the pancreas.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- **Still seen:**

1. Proximal left ureteric intraluminal soft tissue lesion with moderate left pelvicalyceal system dilatation seen inseparable from the relatively focally thickened left psoas muscle.
2. Mild fullness of right renal pelvis with suspected intraluminal ureteric similar soft tissue lesions as described.
3. Mildly enlarged left para-aortic lymph nodes, the largest currently measures about 7 x 12 mm
4. Bulky left supra-renal gland.

- Normal appearance of the spleen, right adrenal gland and the pelvic organs.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No pathologically enlarged pelvic lymph nodes.
- Theco-peritoneal shunt tube is **still noted** entering the spinal canal at L3 level, travels subcutaneously (surrounded by right anterior wall lumbar region fat smudging) and enters the peritoneal cavity with its tip reaching seen at the pelvis.
- **Regression of the:**

1. Amount of the mild peri-hepatic, right para-colic, perisplenic and pelvic ascites.
2. Diffuse omental fat smudging being extensive at right lumbar and right iliac fossa location with related thickened peritoneal reflection.

- **Stationary course** regrading bilateral adnexal cystic lesions with internal enhancing nodular lesions, the larger is the right one still measuring about 31 X 27 mm.

The revised bone window revealed:

- **Stationary** size and number of widespread axial and proximal

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
٤ شارع علوية أول شارع الهرم بجوار دارى . الجيزة
مركز بهية الشيخ زايد
١٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

PATIENT NAME: MANAL AHMED ALSHIEKH MOHAMMED GENDER: Female DATE : 28-Feb-2026 09:44 AM	PATIENT ID: 10124249461 AGE: 45 y ORDER: 3770267,3770268,3770269

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE BRAIN, CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

**** As compared to previous study dated 20/09/2025, the current study shows:**

FINDINGS:

1- BRAIN:

- No focal cerebral areas of abnormal density or abnormal enhancement pattern.
- No extra-axial or intra-cerebral areas of fresh blood densities.
- Prominent ventricular system and extra axial CSF spaces namely the cortical sulci, basal cistern and sylvian fissures.
- No midline shift.
- Unremarkable posterior fossa structures.

2- CHEST:

- **Regressive course of the** right breast inframammary lesion inseparable from underlying pectoral muscle measuring 21 x 14 mm compared to 25 x 19 mm previously.
- **Stationary course regarding:**

1. Bilateral dense breasts with stationary other multicentric enhancing soft tissue nodules/masses; the largest in left breast seen measuring 15 x 14 mm.
2. Prominent right axillary lymph nodes level I ; the largest measuring 11 x 6 mm. related marked fat smudging is noted.
3. Prominent left axillary lymph nodes levels I and II; the largest at level I measuring 15 X 9 mm.

- Currently noted bilateral lower lobes posterior segment atelectasis with ground glass densities likely gravitational.
- No sizable suspicious pulmonary nodules.
- No pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
٨ شارع عادلية أول شارع الهرم بجوار داري ، الجيزة
مستشفى دوله الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

appendicular skeleton sclerotic lesions.
- No CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

*** Status follow up showing*

- *Regressive course of the:*

1. *Right breast inframammary lesion.*
2. *Anterior mediastinal soft tissue density, likely prominent thymus tissue.*
3. *Amount of the mild peri-hepatic, right para-colic, perisplenic and pelvic ascites.*
4. *Diffuse omental fat smudging.*

- *Stationary rest of the study.*

Reported By,
Dr. Ali Saber, MSc
Dr. Reham Anwar, FEBR, MD 03-Mar-2026 01:50 PM

www.Baheya.org 16602
مركز بهية للهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري - الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 15/7/2025 G

Name	[illegible]	MRN	C·C0[illegible]
		ID	CN··[illegible]
Age	45	Phone	0100 838 4266
Menopausal status	Premenopausal	Marital status	
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	ReMDT
CO morbidity	irrelevant		

Clinical Data

BX: IDC G II

ER: 8/8	PR: 8/8	HER 2: -ve	KI 67: 15%

Sonomammography:

Mets Workup:

Denovo MBC (10/2024) → Bone, Brain, ovaries

R (PsI) L

TNM

Recommendations: AI, Zoladex → (5/2025) ⇒ shifted to PD ribo only

Fasludex in Bahya and referred for Ibrance.

MDT OUTCOME & PLAN

For Ibrance. / Fasludex / Zometa

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
[illegible]	Dr Hadi 15/7/2025				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

National ID – Front [DOCTYPE.ID_FRONT]

Initial Assessments

٢٨٠٠٧٢٩٢٣٠٠٤٤١ ٢٠٢٥/٠١

بكالوريوس خدمه اجتماعيه

أنثى مسلمة أنسة

٩ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠١/٢٣

Initial
Assessments